**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) ***

# طلب علاج أول مرة / متردد

**إسم المريض رباعياً :** عديله حلمى امين احمد
**المحافظة :** الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** -
**رقم البطاقة :** 26704252100941 **رقم التليفون :** 01114141514 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 25-04-1967 **المهنة :** بدون عمل

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي** **المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------) **التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**خطة العلاج :** أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

**Name:** عديله حلمى امين احمد
**National ID:** 26704252100941

## تقرير طبي

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | |
|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | **بشأن تقرير طبي للمريض** |
| **بقسم:** | **رقم طبي:** |

**نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | |
|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** -- --:-- yyyy-mm-dd | **تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026 |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة**

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.**

| | |
|---|---|
| **التاريخ :** **05-07-2026** | **الوقت :** -- --:-- |
| | **الطبيب المعالج :** د/شيماء لاشين |

dele Helmy Amin Ahmed

026-09-12

of.Dr. no doctor

oustave Roussey International Egypt



's Name: Adele Helmy Amin Ahmed

' by: 2026-09-12

Prof.Dr. no doctor

Goustave Roussey International Egypt



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | عديله حلمى امين | **Case No.** | 407312 |
| **Sex/Age** | Female 59 Y | **Patient No.** | 30602 |
| **Registered Date** | 26/9/2026 09:43:24 AM | **Referred By Dr.** | Interventional Radiology |
| **Validation Date** | 11/10/2026 09:01:01 AM | **Branch** | Gustave Roussy |
| **Reporting Date** | 15/10/2026 11:06:29 AM | **Pathology No.** | 3093/26 |

**- Her2: Low (score 1+).**
**- Ki67%: 5%.**

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
** *Scoring system: "Her2"*
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

*Signature*
***Prof. Dr. Maha Guimei, MD, PhD.***



407312|6313|
10/15/2026
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | عديله حلمى امين | **Case No.** | 407312 |
| **Sex/Age** | Female 59 Y | **Patient No.** | 30602 |
| **Registered Date** | 26/9/2026 09:43:24 AM | **Referred By Dr.** | Interventional Radiology |
| **Validation Date** | 11/10/2026 09:01:01 AM | **Branch** | Gustave Roussy |
| **Reporting Date** | 15/10/2026 11:06:29 AM | **Pathology No.** | 3093/26 |

# Pathology Report

**Clinical Data:** Left breast mass, Tru cut biopsy.

**Nature of Specimen**: Tru-cut biopsy, collected on 26/09/2026, at 9:43 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

**Gross Examination:**
- Two grey, white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

**Technique:**
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

**Microscopic examination:**
**-Histologic type:** Invasive duct carcinoma with lobular differentiation.
**- Histologic grade:** 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2).
**- Ductal carcinoma in situ:** Absent.
**- Microcalcification**: Absent.
**- Angioinvasion:** Absent.
**- Perineural invasion:** Absent.
**- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** 1%.

**Results:**
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Weak incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 5%.

**Conclusion:**
**Left breast mass, Tru-cut biopsy:**
**- Invasive duct carcinoma, with lobular differentiation, Grade 2.**
**IPT:**
**- ER: Positive (score 8/8).**
**- PR: Positive (score 8/8).**

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
glab.192.168.1.113.l.gla.bz/print/PrintReport?reportId=407312|6313|&template=Pathology

[[DOCTYPE:PATHOLOGY REPORT]]

| | |
|---|---|
| **Patient's Name:** | **Adele Helmy Amin Ahmed** |
| **Date:** | **2026-09-12** |
| **Referred by:** | Prof.Dr. **no doctor** |
| **Hospital:** | **Goustave Roussey International Egypt** |

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

**Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:**

**Clinical summary:** -old female with left breast palpable lump

**Findings:**

Left **breast.**

- Scattered fibroglandular densities. (ACRb)
  - LIQ irregular speculater dense mass with underlying architectural distortion
  - UOQ area of asymmetry .
  - Thickened skin and retacted nipple
- **Ultrasound** demonstrated shows two irregular hypo echoic solid lesion seen
- **One is seen at LIQ 4 o'lock para areolar irregular spiculated heterogenous hypoechoc non parallel with internal microcalcifications**
- **A larger LOQ 7 o'clock similar lesion measuring about 3.c cm x3 cm .**
- **Thickened skin 6 mm and retracted nipple .**
- **multiple level 1 pathological enlarged LNs nodes seen one of them with extra capsular rupture measuring 13 mm x 9 mm and the largest measuring 23x13x6 mm**
- Right **breast.**
  - Scattered fibroglandular densities. (ACRb)
  - No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
  - **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
  - **Retro areolar dilated ducts**
  - Normal skin/nipple/areola complex.
  - Non-specific axillary LNs.

***Conclusion: -***

- left ***breast (BIRADS 4c): two malignant looking lesion ( localy advanced ) for biopsy and CESM study***
- **right *breast (BIRADS 1): Normal study.***

**Best Regards,**

**DR. Dina SAYED ,Msc ,CUDBIT**

| | |
|---|---|
| **Patient's Name:** | **Adele Helmy Amin Ahmed** |
| **Date:** | **2026-09-12** |
| **Referred by:** | Prof.Dr. **no doctor** |
| **Hospital:** | **Goustave Roussey International Egypt** |

Mammogram
[DOCTYPE:MAMMOGRAM]

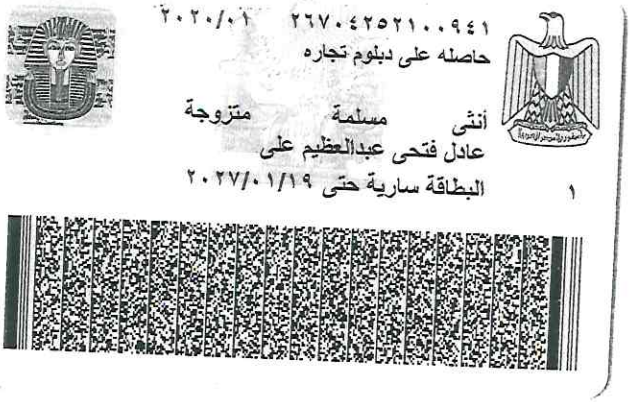

جمهورية مصر العربية
بطافة تحقيق الشخصية

عديله
حلمى امين احمد
٤٠ش محمد عبدالصمد-مساكن كفرطهرمس
بولاق الدكرور - الجيزه

٢٦٧ ٠٤ ٢٥ ٢١ ٠٠٩ ٤١

II2702977

٠١١١٤١٤١٥١٤
٠١١٠٤٣٠٤٥٨


٢٦٧٠٤٢٥٢١٠٠٩٤١ ٢٠٢٠/٠١
حاصله على دبلوم تجاره

أنثى مسلمة متزوجة
عادل فتحى عبدالعظيم على
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠١/١٩

١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

| | |
|---|---|
| **Patient's Name:** | **Adele Helmy Amin Ahmed** |
| **Date:** | **2026-09-12** |
| **Referred by:** | Prof.Dr. **no doctor** |
| **Hospital:** | **Goustave Roussey International Egypt** |

## Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

**Clinical summary:** -old female with left breast palpable lump

**Findings:**

Left **breast.**

- Scattered fibroglandular densities. (ACRb)
  - LIQ irregular speculater dense mass with underlying architectural distortion
  - UOQ area of asymmetry .
  - Thickened skin and retacted nipple
- **Ultrasound** demonstrated shows two irregular hypo echoic solid lesion seen
- **One is seen at LIQ 4 o'lock para areolar irregular spiculated heterogenous hypoechoc non parallel with internal microcalcifications**
- **A larger LOQ 7 o'clock similar lesion measuring about 3.c cm x3 cm .**
- **Thickened skin 6 mm and retracted nipple .**
- **multiple level 1 pathological enlarged LNs nodes seen one of them with extra capsular rupture measuring 13 mm x 9 mm and the largest measuring 23x13x6 mm**
- Right **breast.**
  - Scattered fibroglandular densities. (ACRb)
  - No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
  - **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
  - **Retro areolar dilated ducts**
  - Normal skin/nipple/areola complex.
  - Non-specific axillary LNs.

***Conclusion: -***

- left ***breast (BIRADS 4c): two malignant looking lesion ( localy advanced ) for biopsy and CESM study***
- **right *breast (BIRADS 1): Normal study.***

Best Regards,

**DR. Dina SAYED ,Msc ,CUDBIT**

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]